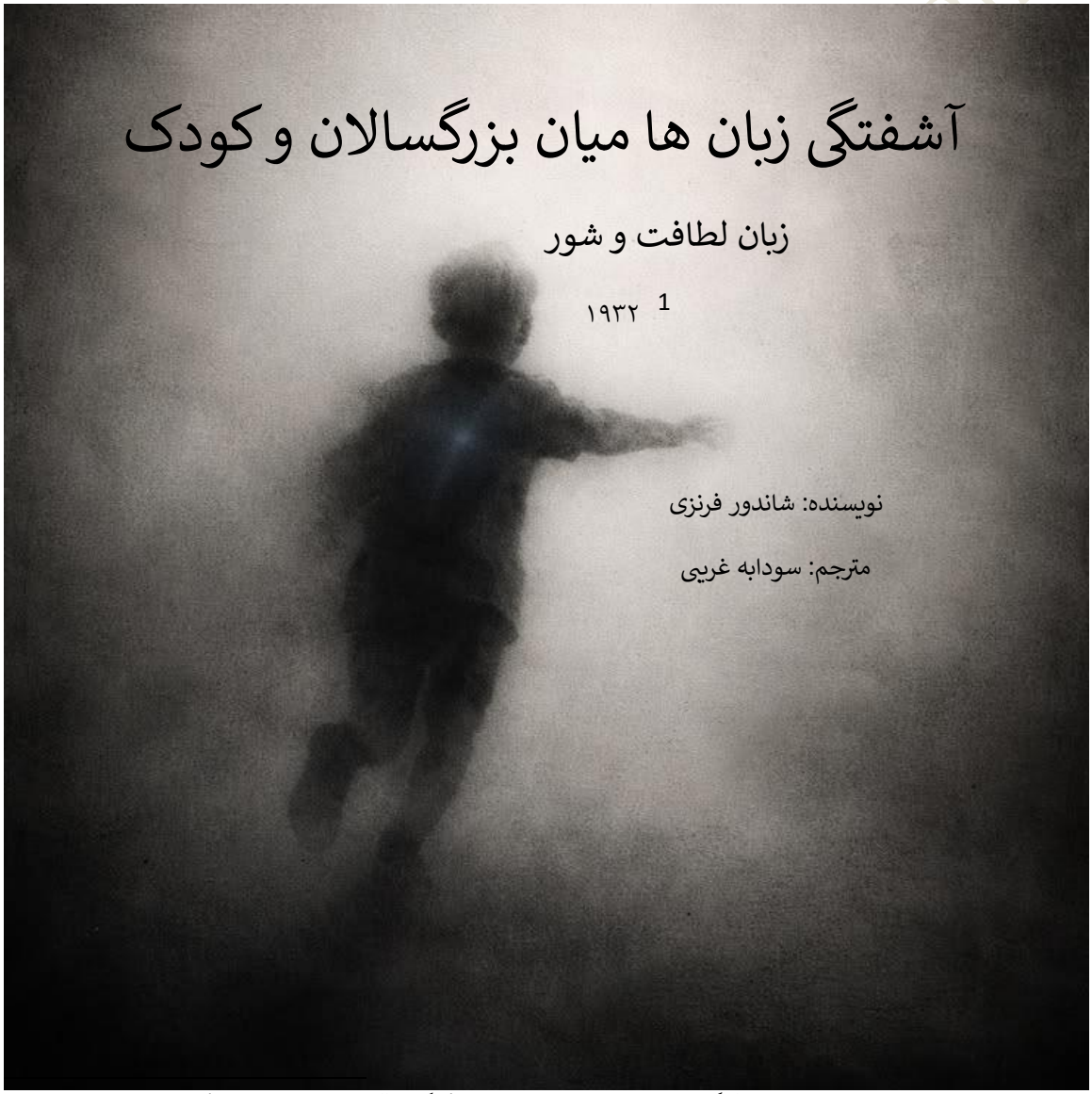


[1] این مقاله نخستین بار در سال ۱۹۳۲ در دوازدهمین کنگرهٔ بین‌المللی روان‌کاوی ارائه شد و ترجمهٔ انگلیسی آن در سال ۱۹۴۹ در مجلهٔ *International Journal of Psycho-Analysis*، جلد ۳۰، صفحات ۲۲۵–۲۳۰ منتشر شد. ترجمهٔ فارسی حاضر بر اساس نسخهٔ انگلیسی سال ۱۹۴۹ انجام شده است.

کوشش برای گنجاندن موضوع بسیار گستردهٔ منشأ برون‌زادِ شکل‌گیری منش و روان‌رنجوری‌ها در یک مقالهٔ کنگره‌ای اشتباه بود. بنابراین به ارائهٔ گزیده‌ای کوتاه از آنچه می‌بایست دربارهٔ این موضوع بگویم بسنده خواهم کرد. شاید بهتر باشد با توضیح اینکه چگونه به مسئله‌ای رسیدم که در عنوان این مقاله بیان شده است آغاز کنم. در سخنرانی‌ای که به مناسبت هفتادوپنجمین زادروز پروفسور فروید در انجمن روان‌کاوی وین ایراد کردم، از بازگشتی در فنون(و تا اندازه‌ای نیز در نظریهٔ) روان‌رنجوری‌ها گزارش دادم که برخی نتایج نامطلوب یا ناقص در کار با بیمارانم مرا به آن واداشته بود. منظورم تأکید تازه و نیرومندتر بر عوامل تروماتیک در بیماری‌زایی روان‌رنجوری‌هاست؛ عواملی که در سال‌های اخیر به‌ناروا مورد غفلت قرار گرفته بودند. کاوش ناکافی و عمیق‌نبودن بررسی عامل برون‌زاد، خطر توسل زودهنگام به توضیحاتی ـ اغلب بیش از حد آسان‌گیرانه برحسب"آمادگی" و"سرشت"را به همراه دارد.

پدیده‌هایی که می‌خواهم آن‌ها را تکان‌دهنده بنامم، یعنی تکرارهای تقریباً توهم‌گونِ تجربه‌های تروماتیک که در کار روزانه‌ام رو به افزایش گذاشته بودند، چنین امیدی را موجه می‌نمودند که به یاری این تخلیهٔ عاطفی، مقادیر فراوانی از عواطف واپس‌رانده بتوانند در ذهن هشیار پذیرفته شوند و شکل‌گیری‌سمپتوم های تازه، به‌ویژه هنگامی که روساخت عواطف در اثر کار تحلیلی به اندازهٔ کافی سست شده باشد، پایان یابد. متأسفانه این امید تنها به‌شکلی بسیار ناقص تحقق یافت و بعضی از بیمارانم موجب نگرانی و شرمندگی فراوان من شدند.تکراری که تحلیل تشویقش می‌کرد، از حد می‌گذشت. درست است که برخی‌سمپتوم ها به‌طور محسوسی بهبود یافته بودند؛ اما از سوی دیگر، این بیماران دچار حمله‌های اضطرابی شبانه و حتی کابوس‌های شدید شدند و جلسهٔ تحلیلی بارها و بارها به حمله‌ای از هیستری اضطرابی بدل شد. با آنکه توانستیم‌سمپتوم های تهدیدکنندهٔ چنین حمله‌ای را بادقت حرفه ای تحلیل کنیم ـ سمپتوم هایی که ظاهراً بیمار را قانع و آسوده می‌کردند ـ موفقیت پایداری که انتظارش را داشتیم حاصل نشد و صبح روز بعد همان شکایت‌ها از شب هولناک تکرار می‌شد، درحالی‌که در جلسهٔ تحلیلی نیز تروما دوباره تکرار می‌شد. در این وضعیت دشوار طبق معمول خودم را با این توضیح تسلی می‌دادم که مقاومت بیمار بسیار شدید است یا او از واپس‌رانی‌هایی چنان سخت رنج می‌برد که تخلیهٔ عاطفی و ورود محتوا به هشیاری تنها می‌تواند به‌تدریج روی دهد. اما چون وضعیت بیمار، حتی پس از گذشت زمانی قابل‌توجه، در اساس تغییری نمی‌کرد ناچار شدم به خودانتقادی میدان بدهم. شروع کردم به گوش‌دادن به بیمارانم، هنگامی که در جریان حمله‌هایشان مرا بی‌احساس، سرد، و حتی سخت‌دل و بی‌رحم می‌نامیدند؛ هنگامی که مرا به خودخواهی، بی‌عاطفگی و خودپسندی سرزنش می‌کردند؛ هنگامی که فریاد می‌زدند: "!کمک !زود !نگذارید بی‌پناه از میان بروم" آنگاه شروع کردم به زیرسوال بردن خودم تا دریابم آیا با وجود همهٔ نیت‌های خیرخواهانهٔ خودآگاهانه‌ام، ممکن است سرانجام حقیقتی در این اتهام‌ها نهفته باشد. باید اضافه کنم که چنین دوره‌هایی از خشم و نفرت فقط استثنائاً رخ می‌دادند؛ اغلب جلسه‌ها با اطاعتی چشمگیر و تقریباً درمانده‌وار و آمادگی برای پذیرش تفسیرهای من پایان می‌یافتند. اما این وضعیت چنان گذرا بود که دریافتم حتی این بیماران ظاهراً همراه نفرت و خشم احساس می‌کنند، و شروع کردم به تشویق آنان که به هیچ روی ملاحظهٔ مرا نکنند. این تشویق هم دستاورد چندانی نداشت، زیرا بیشتر بیمارانم با قاطعیت از پذیرش چنین درخواست تفسیری‌ای سر باز می‌زدند، هرچند متریال‌تحلیلی به‌خوبی از آن پشتیبانی می‌کرد .

بنابراین به‌تدریج به این نتیجه رسیدم که بیماران نسبت به آرزوها، گرایش‌ها، هوس‌ها، همدلی‌ها و بیزاری‌های تحلیلگرشان حساسیتی فوق‌العاده ظریف دارند، حتی اگر خود تحلیلگر از این حساسیت کاملاً بی‌خبر باشد. بیماران به‌جای مخالفت با تحلیلگر یا متهم‌کردن او به خطا و ندیدن مساله با او همانندسازی می‌کنند؛ فقط در لحظه‌های نادرِ برانگیختگی هیستریک یعنی در حالتی تقریباً ناهشیار، می‌توانند آن‌قدر جرئت پیدا کنند که اعتراض کنند؛ در حالت عادی به خود اجازه نمی‌دهند از ما انتقاد کنند و چنین انتقادی حتی در آنان خودآگاه نمی‌شود، مگر آنکه اجازه‌ای ویژه یا حتی تشویقی به چنین جسارتی به آن‌ها بدهیم. این بدان معناست که باید از خلال تداعی‌های آنان نه‌فقط رویدادهای دردناک گذشته‌شان، بلکه همچنین و بسیار بیش از آنچه تاکنون تصور می‌شد انتقاد واپس‌رانده یا سرکوب‌شدهٔ آنان از خودمان را تشخیص دهیم.

اما در اینجا با مقاومت‌های چشمگیری روبه‌رو می‌شویم؛ این بار مقاومت‌هایی هم در خود ما و هم در بیمارانمان. پیش از هر چیز، خود ما باید واقعاً تا ژرف‌ترین لایه‌ها تحلیل شده باشیم. باید یاد گرفته باشیم همهٔ ویژگی‌های ناخوشایند بیرونی و درونی منش خود را بشناسیم تا حقیقتاً آمادهٔ مواجهه با همهٔ آن صورت‌های نفرت و تحقیر پنهان باشیم که می‌توانند با چنان زیرکی در تداعی‌های بیمارانمان تغییر چهره دهند.

این موضوع ما را به مسئله‌ای فرعی می‌رساند ـ تحلیلِ تحلیلگر ـ که روزبه‌روز اهمیت بیشتری می‌یابد. فراموش نکنیم که تحلیل عمیق یک روان‌رنجوری به سال‌های بسیار نیاز دارد، حال آنکه تحلیل آموزشی به‌طور متوسط تنها چند ماه یا حداکثر یک تا یک‌ونیم سال طول می‌کشد.:این امر ممکن است به وضعیتی ناممکن بینجامد، بیماران ما به‌تدریج بهتر از خود ما تحلیل می‌شوند؛ یعنی با آنکه ممکن است نشانه‌هایی از این برتری را نشان دهند، قادر نیستند آن را در قالب کلمات بیان کنند؛ بلکه آشکارا به اطاعت‌پذیری افراطی تنزل می‌کنند، زیرا یا توانایی بیان آن را ندارند یا می‌ترسند انتقادشان موجب ناخشنودی ما شود.

بخش بزرگی از انتقاد واپس‌رانده‌ای که بیمارانمان احساس می‌کنند متوجه چیزی است که می‌توان آن را"ریاکاری حرفه‌ای" نامید. هنگامی که بیمار وارد اتاق ما می‌شود، با ادب از او استقبال می‌کنیم، از او می‌خواهیم تداعی‌هایش را آغاز کند و صادقانه به او قول می‌دهیم با توجه به سخنانش گوش دهیم و علاقهٔ کامل خود را به بهروزی او و کاری که برای آن لازم است معطوف کنیم. بااین‌حال، در واقع ممکن است برخی ویژگی‌های بیرونی یا درونی بیمار را تنها به‌دشواری تحمل کنیم یا شاید در جلسهٔ تحلیلی، مسئله‌ای حرفه‌ای یا شخصی به‌شکلی ناخوشایند آشفته‌مان کند. در اینجا نیز راه‌حلی جز آن نمی‌بینم که منشأ آشفتگی درون خود را کاملاً به‌خود آگاهی بیاوریم و آن را با بیمار در میان بگذاریم، و شاید نه‌فقط به‌عنوان امکانی محتمل بلکه به‌عنوان واقعیتی موجود بپذیریم.

شگفت‌آور است که چنین چشم‌پوشی‌ای از"«ریاکاری حرفه‌ای" ـ ریاکاری‌ای که تا آن زمان اجتناب‌ناپذیر شمرده می‌شد ـ به‌جای آسیب‌رساندن به بیمار، به تسکینی محسوس در وضعیت او انجامید. حملهٔ هیستریکِ تروماتیک، حتی اگر تکرار می‌شد، به‌مراتب خفیف‌تر بود؛ رویدادهای تراژیک گذشته می‌توانستند در اندیشه بازتولید شوند، بی‌آنکه بار دیگر موجب ازدست‌رفتن تعادل روانی شوند؛ درواقع به نظر می‌رسید سطح شخصیت بیمار به‌طور چشمگیری ارتقا یافته است.

اکنون چه چیزی این وضعیت را پدید آورده بود؟ در رابطهٔ میان پزشک و بیمار چیزی ناگفته مانده بود، چیزی غیرصادقانه و گفت‌وگوی بی‌پرده، به‌اصطلاح، زبان بیمارِ زبان بسته را گشود، پذیرش خطای تحلیلگر در بیمار او اعتماد ایجاد کرد. تقریباً چنین به نظر می‌رسید که گاه اشتباه‌کردن سودمند است تا بتوان پس از آن به خطای خود نزد بیمار اعتراف کرد. البته این تدبیر کاملاً زائد است؛ ما به‌اندازهٔ کافی اشتباه می‌کنیم و یکی از بیماران بسیار باهوش من به‌حق خشمگین شد و گفت" خیلی بهتر بود اگر می‌توانستید اصلاً مرتکب اشتباه نشوید. خودپسندی شما، دکتر، می‌خواهد حتی از خطاهایتان هم سود ببرد."

کشف و حل این مسئلهٔ صرفاً فنی، برخی مطالب پیش‌تر پنهان یا به‌ندرت مورد توجه را آشکار کرد. موقعیت تحلیلی ـ یعنی خونسردیِ مهارشده، ریاکاری حرفه‌ای و بیزاری از بیمار که در پس آن پنهان است اما هرگز آشکار نمی‌شود، بااین‌حال بیمار آن را با تمام وجود احساس می‌کند ـ چنین موقعیتی اساساً تفاوتی با وضعیتی نداشت که در کودکی او به بیماری انجامیده بود. هنگامی که علاوه بر فشار ناشی از این موقعیت تحلیلی، بار اضافیِ بازتولید ترومای اولیه را نیز بر بیمار تحمیل می‌کردیم وضعیتی می‌آفریدیم که واقعاً تحمل‌ناپذیر بود. چندان شگفت نیست که تلاش ما نتایجی بهتر از خود ترومای اولیه به بار نمی‌آورد. آزادگذاشتن احساسات انتقادی او، آمادگی ما برای پذیرفتن اشتباهاتمان و کوشش صادقانه برای پرهیز از آن‌ها در آینده، همه در ایجاد اعتماد بیمار به تحلیلگر سهم دارند. این اعتماد است که تضاد میان اکنون و گذشتهٔ تحمل‌ناپذیرِ ترومازا را برقرار می‌کند؛ تضادی که برای بیمار مطلقاً ضروری است تا بتواند گذشته را دیگر نه به‌شکل بازتولیدی توهم‌گون بلکه همچون خاطره‌ای عینی دوباره تجربه کند. انتقادهای سرکوب‌شدهٔ بیمارانم، مثلاً کشفِ با بصیرتی غریب از ویژگی‌های پرخاشگرانهٔ"درمان فعال" من و ریاکاری حرفه‌ای نهفته در تحمیل آرمیدگی، به من آموخت که اغراق‌ها را در هر دو جهت

بشناسم و مهار کنم. همچنین از بیمارانی سپاسگزارم که به من آموختند ما بیش از اندازه مایلیم سخت‌گیرانه به برخی ساختارهای نظری بچسبیم و واقعیت‌هایی را که ممکن است رضایت خاطر و اقتدار ما را خدشه‌دار کنند، نادیده بگیریم. به‌هرحال، علت ناتوانی خود در تأثیرگذاشتن بر فوران‌های هیستریک را دریافتم و این کشف سرانجام موفقیت را ممکن ساخت. برای من همان اتفاق افتاد که برای آن زن دانا رخ داد که دوستش را هیچ مقدار تکان‌دادن و فریادزدن نمی‌توانست از خواب نارکولپتیک بیدار کند؛ ناگهان به فکرش رسید که فریاد بزند"!لالایی، کوچولوی من" پس از آن بیمار شروع کرد به انجام هر کاری که از او خواسته می‌شد.

ما در تحلیل، بسیار دربارهٔ واپس‌روی به وضعیت کودکی سخن می‌گوییم، اما واقعاً باور نداریم که تا چه اندازه حق با ماست؛ بسیار دربارهٔ دوپارگی شخصیت سخن می‌گوییم، اما به نظر نمی‌رسد عمق این دوپارگی‌ها را به‌اندازهٔ کافی درک کنیم. اگر حتی در مواجهه با بیماری که در وضعیت اپیستوتونیک قرار دارد، نگرش سرد و آموزش‌گرانهٔ خود را حفظ کنیم، آخرین رشته‌ای را که او را به ما پیوند می‌دهد، پاره می‌کنیم. بیماری که به حالت خلسه فرو رفته است، به‌راستی کودکی است که دیگر به توضیحات عقلانی واکنش نشان نمی‌دهد؛ شاید تنها به مهربانی مادرانه پاسخ دهد. بدون آن، او در لحظهٔ شدیدترین نیاز خود، احساس تنهایی و رهاشدگی می‌کند؛ یعنی خود را در همان وضعیت تحمل‌ناپذیری می‌یابد که زمانی به دوپارگی روان او و سرانجام به بیماری‌اش انجامیده بود. بنابراین، شگفت‌آور نیست که بیمار اکنون ناگزیر است شکل‌گیری‌سمپتوم ها را دقیقاً همان‌گونه تکرار کند که در زمان آغاز بیماری‌اش رخ داده بود.

اجازه دهید یادآوری کنم که بیماران به عبارت‌های نمایشی واکنش نشان نمی‌دهند، بلکه تنها به همدلی واقعی و صمیمانه پاسخ می‌دهند. اینکه آنان حقیقت را از آهنگ یا رنگ صدای ما، از واژه‌هایی که به کار می‌بریم یا به شیوه‌ای دیگر تشخیص می‌دهند، نمی‌توانم بگویم به‌هرحال، آنان آگاهی شگفت‌انگیز و تقریباً روشن‌بینانه‌ای از افکار و هیجان‌هایی نشان می‌دهند که در ذهن تحلیلگرشان جریان دارد. فریب‌دادن بیمار از این حیث تقریباً ناممکن به نظر می‌رسد و اگر کسی چنین تلاشی کند تنها پیامدهای نامطلوبی به بار می‌آورد.

اکنون اجازه دهید برخی اندیشه‌های تازه‌ای را بیان کنم که این رابطهٔ صمیمانه‌تر با بیمارانم به من کمک کرد تا به آن‌ها دست یابم.

بیش از هر چیز، شواهد تأییدکنندهٔ تازه‌ای برای این فرض خود به دست آوردم که اهمیت تروما، به‌ویژه ترومای جنسی به‌عنوان عاملی بیماری‌زا را هرقدر هم زیاد ارزیابی کنیم، باز کافی نیست. حتی کودکان خانواده‌های بسیار محترم و صادقانه پایبند به اصول سخت‌گیرانهٔ اخلاق، بسیار بیش از آنچه پیش‌تر جرئت می‌کردیم تصور کنیم، قربانی خشونت واقعی یا تجاوز جنسی می‌شوند. گاه این والدین هستند که می‌کوشند ناکامی خود را از این راه آسیب‌شناختی به‌گونه‌ای جایگزین ارضا کنند؛ و گاه اشخاصی که قابل‌اعتماد پنداشته می‌شوند، مانند خویشاوندان(عموها، عمه‌ها، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها) مربیان ، سرخانه یا خدمتکاران، از ناآگاهی و معصومیت کودک سوءاستفاده می‌کنند. توضیح فوریِ این رخدادها، مبنی بر اینکه آن‌ها صرفاً خیال‌پردازی‌های جنسی کودک، یعنی نوعی دروغ‌گویی هیستریک هستند، متأسفانه با شمار چنین اعتراف‌هایی، برای مثال اعتراف به تعرض به کودکان از سوی بیمارانی که واقعاً تحت تحلیل قرار دارند، بی‌اعتبار می‌شود. به همین دلیل، هنگامی که اخیراً معلمی نیکوکارانه‌اندیش با نومیدی به من گفت که در مدت کوتاهی دریافته است در پنج خانوادهٔ طبقهٔ بالا، مربیان سرخانه با پسران نُه تا یازده‌ساله روابط جنسی منظمی داشته‌اند، شگفت‌زده نشدم.

یکی از شیوه‌های معمولی که اغواگری‌های محارم‌آمیز ممکن است به آن صورت رخ دهند، چنین است: یک بزرگسال و یک کودک یکدیگر را دوست دارند و کودک خیال‌پردازی بازیگوشانه‌ای را در سر می‌پروراند که در آن نقش مادرِ بزرگسال را بر عهده می‌گیرد این بازی ممکن است صورت‌هایی اروتیک به خود بگیرد، اما بااین‌حال در سطح مهرورزی باقی می‌ماند.

اما در مورد بزرگسالان آسیب‌مند چنین نیست، به‌ویژه اگر تعادل و خویشتن‌داری آنان بر اثر مصیبتی یا مصرف مواد مست‌کننده مختل شده باشد. آنان بازی کودکان را با امیال شخصی که از نظر جنسی بالغ است اشتباه می‌گیرند، یا حتی به خود اجازه می‌دهند، بی‌اعتنا به هرگونه پیامدی، عنان اختیار از کف بدهند. تجاوز واقعی به دخترانی که به‌زحمت از دوران خردسالی فراتر رفته‌اند، اعمال جنسی مشابه از سوی زنان بالغ با پسران، و همچنین اعمال همجنس‌خواهانهٔ تحمیلی رخدادهایی بسیار شایع‌تر از آن چیزی هستند که تاکنون تصور می‌شده است.

تصور رفتار و هیجان‌های کودکان پس از چنین خشونتی دشوار است. انتظار می‌رود نخستین تکانهٔ آنان طردکردن، نفرت انزجار و امتناع قاطعانه باشد"نه، نه، من این را نمی‌خواهم؛ این برای من بسیار خشونت‌آمیز است، درد دارد، مرا تنها بگذار" اگر اضطراب عظیم آنان را فلج نمی‌کرد، واکنش فوری‌شان چنین چیزی یا چیزی مشابه آن می‌بود .این کودکان از نظر جسمانی و اخلاقی احساس درماندگی می‌کنند؛ شخصیت آنان هنوز به‌اندازهٔ کافی استحکام نیافته است که بتوانند حتی در اندیشهٔ خود اعتراض کنند، زیرا نیروی غلبه‌ناپذیر و اقتدار بزرگسال آنان را خاموش می‌کند و حتی می‌تواند حواسشان را از آنان بگیرد. بااین‌حال، همین اضطراب، اگر به حد معینی از شدت برسد، آنان را وامی‌دارد که همچون آدم‌واره‌هایی مطیع خود را ،تابع ارادهٔ پرخاشگر کنند، تک‌تک امیال او را حدس بزنند و آن‌ها را برآورده سازند؛ و درحالی‌که کاملاً خود را از یاد برده‌اند با پرخاشگر همانندسازی کنند. از طریق همانندسازی، یا بهتر است بگوییم، درون‌فکنیِ پرخاشگر، او به‌عنوان بخشی از واقعیت بیرونی ناپدید می‌شود و به‌جای آنکه برون‌روانی باشد، درون‌روانی می‌شود؛ سپس این امر درون‌روانی، در حالتی رؤیاگونه، همانند خلسهٔ تروماتیک، تابع فرایند نخستین قرار می‌گیرد؛ یعنی مطابق اصل لذت، می‌تواند با استفاده از توهمات مثبت یا منفی تعدیل یا دگرگون شود .به‌هرحال، حمله به‌مثابه واقعیتی بیرونی و انعطاف‌ناپذیر از میان می‌رود و کودک در خلسهٔ تروماتیک موفق می‌شود وضعیت پیشینِ مهرورزی را حفظ کند.

مهم‌ترین تغییری که در ذهن کودک بر اثر همانندسازیِ آکنده از اضطراب و ترس با بزرگسالِ طرف رابطه پدید می‌آید درون‌فکنیِ احساسات گناهِ بزرگسال است؛ امری که باعث می‌شود بازی‌ای که تا آن هنگام بی‌ضرر بود، اکنون همچون خطایی مستوجب مجازات جلوه کند.

هنگامی که کودک از چنین حمله‌ای به خود می‌آید، احساس سردرگمی شدیدی دارد؛ درواقع، دچار دوپارگی شده است. هم‌زمان بی‌گناه و گناهکار است؛ و اعتمادش به گواهی حواس خود درهم شکسته است. علاوه بر این، رفتار خشن بزرگسالِ طرف رابطه، که از پشیمانی خود رنج می‌برد و خشمگین شده است، کودک را بیش‌ازپیش نسبت به گناه خود آگاه و شرمسارتر می‌کند.

تقریباً همیشه، فرد مرتکب چنان رفتار می‌کند که گویی هیچ اتفاق نیفتاده است و خود را با این فکر تسلی می‌دهد" اوه، او فقط یک کودک است، چیزی نمی‌داند، همه‌چیز را فراموش خواهد کرد." نه‌چندان به‌ندرت، پس از چنین رویدادهایی اغواگر به فردی بیش‌ازحد اخلاق‌گرا یا مذهبی تبدیل می‌شود و می‌کوشد با سخت‌گیری، روح کودک را نجات دهد.

معمولاً رابطه با بزرگسال دومی . در موردی که در بالا نقل شد، مادر . به‌اندازهٔ کافی صمیمانه نیست که کودک بتواند در آن رابطه کمکی بیابد؛ تلاش‌های کم‌جرئت کودک برای دستیابی به چنین کمکی از سوی مادر، به‌عنوان حرف‌هایی بی‌معنا رد می‌شوند. کودکی که مورد سوءاستفاده قرار گرفته است، به آدم‌واره‌ای مکانیکی و مطیع تبدیل می‌شود یا سرکشی می‌کند، اما نمی‌تواند دلایل سرکشی خود را توضیح دهد. زندگی جنسی او رشدنیافته باقی می‌ماند یا صورت‌های انحراف‌یافته به خود می‌گیرد. نیازی نیست که من وارد جزئیات روان‌رنجوری‌ها و روان‌پریشی‌هایی شوم که ممکن است در پی چنین رویدادهایی پدید آیند. بااین‌حال، برای نظریهٔ ما، این فرض اهمیت بسیار زیادی دارد؛ یعنی اینکه شخصیت ضعیف و رشدنیافته به ناخوشایندیِ ناگهانی نه از طریق دفاع، بلکه از طریق همانندسازیِ آکنده از اضطراب و درون‌فکنیِ شخص تهدیدکننده یا پرخاشگر واکنش نشان می‌دهد. تنها به کمک این فرضیه است که می‌توانم بفهمم چرا بیمارانم با چنین سرسختی‌ای از پیروی از توصیهٔ من برای واکنش‌نشان‌دادن به رفتار ناعادلانه یا نامهربانانه با احساس رنج یا نفرت و دفاع، خودداری می‌کردند

بخشی از شخصیت آنان، احتمالاً هستهٔ آن، در رشد خود در سطحی متوقف شده بود که در آن قادر نبود از شیوهٔ واکنش آلوپلاستیک(تغییر دادن محیط بیرون به جای تغییر دادن خود)استفاده کند، بلکه تنها می‌توانست به شیوه‌ای اتوپلاستیک (تغییر دادن خود به جای محیط بیرون)از طریق نوعی تقلید، واکنش نشان دهد. بدین‌ترتیب، به فرض وجود روانی می‌رسیم که تنها ازاید و سوپرایگو تشکیل شده است و ازاین‌رو فاقد توانایی حفظ ثبات خود در مواجهه با ناخوشایندی است؛ درست همان‌گونه که کودک نابالغ، تنها گذاشته‌شدن بدون مراقبت مادرانه و بدون میزان قابل‌توجهی از مهرورزی را تحمل‌ناپذیر می‌یابد. در اینجا ناگزیریم به برخی از اندیشه‌هایی بازگردیم که فروید مدت‌ها پیش مطرح کرده بود و بر اساس آن‌ها، توانایی عشق‌ورزی به ابژه باید مرحله‌ای پیش‌از همانندسازی باشد.

مایلم این مرحله را مرحلهٔ عشقِ منفعلانه به ابژه یا مهرورزی بنامم. ردپاهای عشق به ابژه از همین‌جا آشکارند، اما تنها به شکلی بازیگوشانه در خیال‌پردازی‌ها. ازاین‌رو، تقریباً بدون استثنا، با بازی پنهانیِ قرارگرفتن در جایگاه والدِ هم‌جنس مواجه می‌شویم تا کودک بتواند با والد دیگر ازدواج کند؛ اما باید تأکید کرد که این صرفاً خیال‌پردازی است. در واقعیت، کودکان چنین چیزی را نمی‌خواهند؛ در حقیقت، آنان نمی‌توانند بدون مهرورزی، به‌ویژه مهرورزی‌ای که از جانب مادر می‌آید، سر کنند. اگر عشق بیشتری، یا عشقی از نوعی متفاوت با آنچه کودکان نیاز دارند، در مرحلهٔ مهرورزی به آنان تحمیل شود ممکن است همانند ناکامی یا پس‌گرفتن عشق که در جای دیگری در این ارتباط به آن اشاره شده است، به پیامدهای آسیب‌شناختی بینجامد. پرداختن به جزئیات روان‌رنجوری‌ها و اختلال‌های رشد شخصیت که ممکن است در پیِ تحمیل زودهنگام عشقِ شورمندانه و آکنده از احساس گناه بر کودکی نابالغ و بی‌گناه پدید آیند، ما را بیش‌ازحد از موضوع اصلی بحثمان دور خواهد کرد.

والدین و بزرگسالان، درست همانند ما تحلیلگران، باید بیاموزند که همواره آگاه باشند در پس فرمان‌برداری یا حتی ستایش کودکان، بیماران و شاگردانمان، درست همانند آنچه در پس انتقالِ عشق نهفته است، میل سوزانی برای رهایی از این عشقِ ستمگرانه پنهان شده است. اگر بتوانیم به کودک، بیمار یا شاگرد کمک کنیم تا از واکنش همانندسازی دست بکشد و انتقالِ بیش‌ازحد سنگین را از خود دور کند، آنگاه می‌توان گفت که به هدفِ ارتقای شخصیت به سطحی بالاتر دست یافته‌ایم.

مایلم به‌اختصار به گسترش دیگری در دانشمان اشاره کنم که این مشاهدات امکان‌پذیر ساخته‌اند. مدت‌ها بر این باور بوده‌ایم که نه‌تنها عشقِ تحمیل‌شده، بلکه مجازات‌های تحمل‌ناپذیر نیز به تثبیت‌ها می‌انجامند. اکنون شاید حل این تناقضِ ظاهری ممکن باشد. تخطی‌های بازیگوشانهٔ کودک تنها به‌واسطهٔ مجازات‌های شورمندانه، غالباً خشم‌آلود و تنبیهی، به واقعیتی جدی بدل می‌شوند و در کودکی که تا آن زمان با آسودگیِ خاطر خود را بی‌گناه احساس می‌کرد، به حالات افسردگی می‌انجامند.

بررسی دقیق پدیده‌ها در جریان خلسهٔ تحلیلی به ما می‌آموزد که هیچ شوک یا هراسی بدون ردی از دوپارگی شخصیت وجود ندارد .هیچ تحلیلگری شگفت‌زده نخواهد شد که بخشی از شخص به وضعیت خوشبختیِ پیش از تروما واپس‌روی می‌کند؛ ترومایی که می‌کوشد آن را باطل کند. نکتهٔ شگفت‌انگیزتر آن است که در همانندسازی می‌توان عملکرد سازوکار دومی را مشاهده کرد؛ سازوکاری که من، به‌نوبهٔ خود، از وجودش آگاهی اندکی داشتم. منظورم ظهور ناگهانی و شگفت‌آور توانایی‌های تازه پس از تروماست؛ همچون معجزه‌ای که با تکان‌دادن چوب جادویی رخ می‌دهد، یا مانند کاری که می‌گویند مرتاضان انجام می‌دهند،پیش چشمان ما از دانه‌ای کوچک، گیاهی با برگ‌ها و گل‌هایش می‌رویانند. نیاز شدید و به‌ویژه اضطراب مرگبار ظاهراً این قدرت را دارند که استعدادهای نهفته‌ای را که هنوز سرمایه‌گذاری روانی بر آن‌ها صورت نگرفته است و در ژرف‌ترین سکون در انتظار رشد خود بوده‌اند، ناگهان بیدار و فعال کنند.

هنگامی که کودک در معرض تعرض جنسی قرار می‌گیرد، زیر فشار چنین اضطرار تروماتیکی، ممکن است همهٔ هیجان‌های یک بزرگسال بالغ و تمام کیفیت‌های بالقوهٔ نهفته در خود را که معمولاً به ازدواج، مادری و پدری تعلق دارند، بی‌درنگ پرورش دهد. ازاین‌رو، در برابر واپس‌رویِ آشنای ما، حق داریم از "پیش‌رَویِ تروماتیک" و "بلوغ زودرس" سخن بگوییم طبیعی

است که این امر را با رسیدن زودهنگام میوه‌ای مقایسه کنیم که پرنده یا حشره‌ای به آن آسیب رسانده است. تروما نه‌تنها از نظر هیجانی، بلکه از نظر عقلانی نیز می‌تواند بخشی از شخص را به بلوغ برساند. مایلم در اینجا رویای "کودک دانا" را که چندین سال پیش توصیف کردم یادآوری کنم ؛ رؤیایی که در آن نوزادی تازه‌متولدشده یا کودکی خردسال شروع به سخن‌گفتن می‌کند و درواقع به تمام خانواده حکمت می‌آموزد. ترس از بزرگسالِ بی‌مهار و تقریباً دیوانه، کودک را به‌اصطلاح به روان‌پزشک تبدیل می‌کند و او برای آنکه به چنین کسی بدل شود و از خود در برابر خطرهای ناشی از اشخاص فاقد خویشتن‌داری دفاع کند، باید بداند چگونه کاملاً با آنان همانندسازی کند. به‌راستی باورکردنی نیست که هنوز چه اندازه می‌توانیم از کودکان دانای خود، یعنی روان‌رنجوران، بیاموزیم.

اگر در جریان رشد کودک شمار شوک‌ها افزایش یابد، شمار و انواع دوپارگی‌های شخصیت نیز افزایش می‌یابد و به‌زودی حفظ ارتباط با همهٔ پاره‌ها بدون سردرگمی بسیار دشوار می‌شود؛ هر پاره همچون شخصیتی جداگانه رفتار می‌کند، بی‌آنکه .حتی از وجود پاره‌های دیگر آگاه باشد. سرانجام ممکن است وضعیتی پدید آید که . در ادامهٔ تصویرِ پاره‌پاره‌شدن . به‌درستی بتوان آن را"اتمی‌شدن"نامید. برای آنکه در مواجهه با چنین وضعیتی شهامت خود را از دست ندهیم، به خوش‌بینی فراوانی نیاز است؛ هرچند امیدوارم حتی در اینجا نیز بتوانم رشته‌هایی بیابم که بخش‌های گوناگون را به یکدیگر پیوند دهند.

علاوه بر عشقِ شورمندانه و مجازاتِ شورمندانه، راه سومی نیز برای وابسته‌کردنِ درمانده‌وار کودک به بزرگسال وجود دارد این راه" ارعاب از راه رنج‌کشیدن" تروریسمِ(رنج) است .کودکان ناگزیر احساس می‌کنند باید همهٔ نابسامانی‌های خانواده را سامان دهند و، به‌اصطلاح، بار همهٔ دیگران را بر شانه‌های ظریف خود حمل کنند؛ البته این کار صرفاً از نوع‌دوستیِ محض نیست، بلکه برای آن است که بتوانند بار دیگر از آرامش ازدست‌رفته و مراقبت و توجهی که همراه آن بوده است بهره‌مند شوند. مادری که پیوسته از بدبختی‌های خود شکایت می‌کند، می‌تواند از کودک خویش پرستاری مادام‌العمر بسازد؛ یعنی جانشینی واقعی برای مادر، درحالی‌که منافع حقیقی کودک را نادیده می‌گیرد.

اطمینان دارم . اگر همهٔ این‌ها درست از آب درآید . که ناچار خواهیم شد در فصل‌هایی از نظریهٔ جنسیت و تناسلی‌بودن تجدیدنظر کنیم. برای مثال، انحرافات شاید تنها تا آنجا کودکانه‌اند که در سطح مهرورزی باقی می‌مانند؛ اگر شورمندانه و آکنده از احساس گناه شوند، شاید از پیش حاصل تحریک بیرونی، یعنی تشدیدی ثانوی و روان‌رنجورانه باشند. نظریهٔ .تناسلی‌بودنِ خود من نیز این تفاوت میان مراحل مهرورزی و شور را نادیده گرفته بود. اینکه چه اندازه از سادیسم . مازوخیسم در جنسیتِ روزگار ما ناشی از تمدن است((یعنی تنها از احساسات گناهِ درون‌فکنی‌شده سرچشمه می‌گیرد) و چه اندازه به‌طور خودزاد و خودانگیخته همچون مرحله‌ای مستقل از سازمان‌یافتگی رشد می‌کند، باید به پژوهش‌های آینده واگذار شود.

خوشحال خواهم شد اگر زحمت بررسی آنچه امروز گفتم را در اندیشه و در کار بالینی خود بر عهده بگیرید، و به‌ویژه اگر از توصیه‌ام پیروی کنید که بیش از پیش به شیوهٔ اندیشیدن و سخن‌گفتنِ بسیار پوشیده، اما بسیار انتقادیِ کودکان، بیماران و شاگردانتان توجه کنید و، به‌اصطلاح، زبان آنان را باز کنید .اطمینان دارم که مطالب آموزندهٔ فراوانی به دست خواهید آورد.

این رشتهٔ اندیشه‌ها صرفاً به‌صورت توصیفی به مهرورزیِ اروتیسمِ کودکانه و شورمندیِ جنسیتِ بزرگسال اشاره می‌کند مسئلهٔ ماهیت واقعیِ این تفاوت همچنان گشوده باقی می‌ماند. روان‌کاوی با این اندیشهٔ دکارتی که شورمندی‌ها بر اثر رنج‌کشیدن پدید می‌آیند، به‌آسانی موافقت می‌کند؛ اما شاید ناچار باشد پاسخی برای این پرسش بیابد که چه چیزی عنصر رنج‌کشیدن و همراه آن سادیسم-مازوخیسم را به ارضاهای بازیگوشانه در سطح مهرورزی وارد می‌کند.

استدلالی که در بالا شرح داده شد نشان می‌دهد که، از جمله، احساسات گناه هستند که ابژهٔ عشق را در زندگی اروتیکِ بزرگسال به ابژه‌ای هم برای عشق‌ورزیدن و هم برای نفرت‌ورزیدن بدل می‌کنند؛ یعنی به ابژهٔ هیجان‌های دوسوگرا، حال‌آنکه مهرورزیِ کودکانه هنوز فاقد این شکاف است. این نفرت است که هنگامی که کودک از سوی بزرگسالی مورد عشق‌ورزی قرار

می‌گیرد، به‌گونه‌ای تروماتیک او را غافلگیر و هراسان می‌کند و او را از موجودی که خودانگیخته و معصومانه بازی می‌کند به آدم‌واره‌ای عاشق و گناهکار بدل می‌سازد که با اضطراب از بزرگسال تقلید می‌کند و خویشتن را از یاد می‌برد.

احساسات گناهِ خودِ بزرگسالان و نفرتی که نسبت به کودکِ شریک در اغواگری احساس می‌کنند، رابطهٔ عاشقانهٔ بزرگسالان را برای کودک به کشمکشی هراس‌آور(صحنهٔ نخستین)بدل می‌کند. برای بزرگسال، این کشمکش در لحظهٔ ارگاسم پایان می‌یابد، درحالی‌که جنسیتِ کودکانه ـ در غیاب"کشمکش دو جنس" در سطح پیش‌لذت باقی می‌ماند و تنها ارضاهایی به معنای"سیرشدن"را می‌شناسد، نه احساساتِ ازمیان‌رفتنِ همراه با ارگاسم"نظریهٔ تناسلی‌بودن" که می‌کوشد " کشمکش دو جنس" را بر پایهٔ تبارزایی بنیان نهد، باید این تفاوت میان ارضاهای اروتیکِ کودکانه و عشقِ جفت‌گیریِ بزرگسالانِ آغشته به نفرت را روشن سازد.

Persian Translation SOUDABEH GHARIBI